K2 ou K3-EDTA : impact du type d'anticoagulant sur le dosage de l'HbA1c.

1-H. LAIDANI, 2-S. KENDRI, 3-N. Louaileche , 4-F. DJABI

Laboratoire central, CHU de Sétif. Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas –Sétif 1–

Introduction

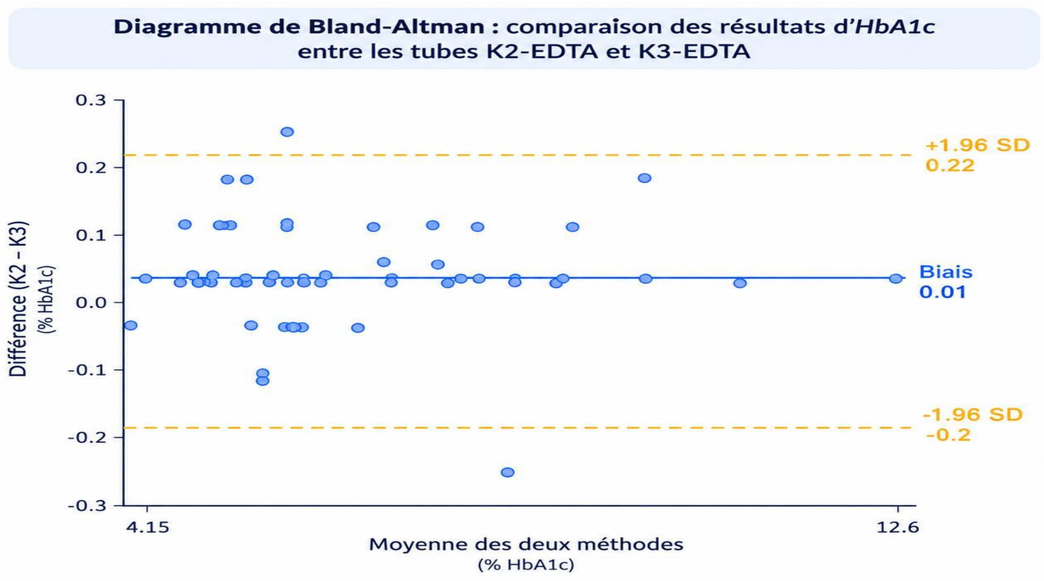
L'hémoglobine glyquée (HbA1c) constitue un paramètre biologique majeur dans le dépistage, le diagnostic et le suivi du diabète. Elle présente l'avantage de ne pas être influencée par les variations glycémiques à court terme. La fiabilité du dosage de l'HbA1c dépend notamment de la qualité du prélèvement et des conditions pré-analytiques. Les tubes K2-EDTA et K3-EDTA sont largement utilisés pour le prélèvement sanguin. Malgré leur utilisation courante, il est important de vérifier que le type d'EDTA n'entraîne pas de différence significative dans les résultats d'HbA1c.

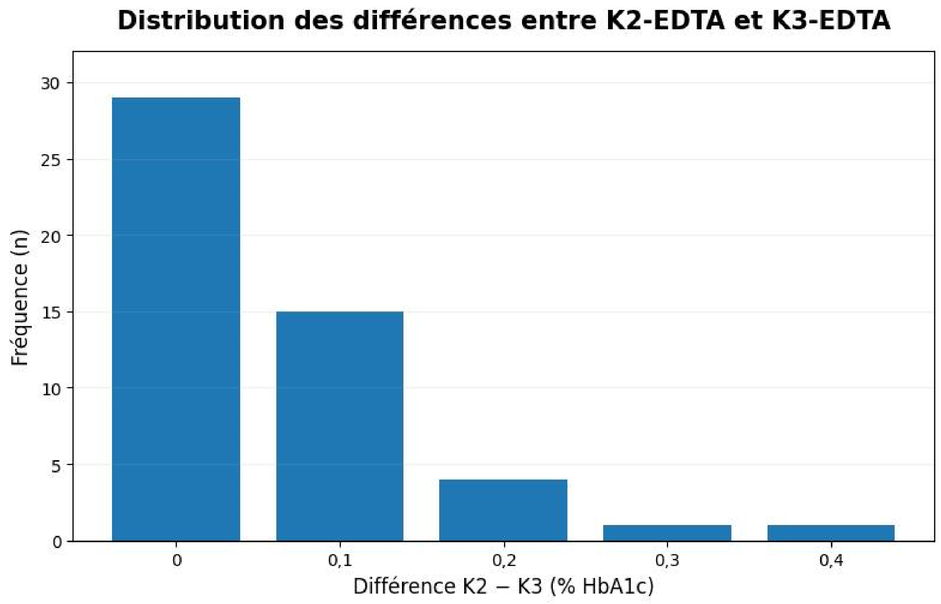
Materiel et méthodes

Une Étude comparative prospective réalisée sur 50 échantillons sanguins destinés au dosage de l'HbA1c. Pour chaque patient, deux prélèvements ont été réalisés simultanément dans des tubes contenant respectivement du K2-EDTA et du K3-EDTA. Les échantillons ont été analysés selon la procédure de routine du laboratoire centrale du Chu de Sétif pour le dosage de l'HbA1c.Les résultats obtenus avec les deux types de tubes ont été comparés par le test de Wilcoxon pour données appariées. La concordance entre les deux types de tubes a été évaluée par l'analyse de Bland-Altman.

Résultats

L'étude a porté sur 50 échantillons analysés simultanément dans des tubes K2-EDTA et K3-EDTA pour le dosage de l'HbA1c. Les résultats obtenus avec les deux types de tubes étaient comparables, avec une moyenne de 6,625 % pour K2-EDTA et de 6,557 % pour K3-EDTA, soit une différence moyenne de 0,066 % HbA1c.
Le test de Wilcoxon n'a pas montré de différence statistiquement significative entre les deux méthodes ($p > 0,05$).
L'analyse de Bland-Altman a montré un biais moyen de +0,01 % HbA1c, avec des limites d'accord à 95 % comprises entre −0,20 et +0,22 % HbA1c. Ces résultats indiquent une bonne concordance entre les tubes K2-EDTA et K3-EDTA pour le dosage de l'HbA1c.





Conclusion

Dans les conditions de cette étude, les tubes K2-EDTA et K3-EDTA donnent des résultats d'HbA1c comparables, sans différence statistiquement significative. Le tube K3-EDTA pourrait ainsi constituer une alternative acceptable au K2-EDTA pour le dosage de l'HbA1c, sous réserve de la validation des performances analytiques dans les conditions propres au laboratoire.